

BRIGADAS INTEGRALES DE EMERGENCIA



PERFIL Y RESPONSABILIDADES DE UNA BRIGADA INTEGRAL

Un brigadista integral es un trabajador voluntario o designado, previamente capacitado, que asume responsabilidades adicionales a su labor cotidiana para actuar de manera organizada ante una emergencia, mientras llegan los organismos de socorro o mientras se resuelve la situación con los propios recursos de la empresa.



PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS

Toda actuación de la brigada debe basarse en algunos principios que no cambian sin importar el tipo de emergencia:

- La vida y la integridad de las personas están siempre por encima de los bienes materiales, el inventario, los medicamentos, el dinero o cualquier equipo.
- Nunca se debe actuar de forma improvisada. Un brigadista sigue procedimientos, no inventa soluciones en el momento.
- La seguridad propia es el primer filtro antes de ayudar a otros: si el brigadista se expone innecesariamente, deja de ser útil para la emergencia y se convierte en una carga adicional para el sistema de respuesta.
- La comunicación oportuna y clara es tan importante como la acción física: alertar a tiempo puede evitar que una situación pequeña se convierta en una emergencia mayor.
- Toda decisión debe tomarse evaluando primero la escena: qué está pasando, qué riesgos hay, y si es seguro intervenir.



El principio "Proteger – Alertar – Socorrer" (PAS)



EVACUACIÓN



EVACUACIÓN: ACTUACIÓN SEGURA



1. ¿QUÉ ES EVACUAR?



Desplazarse de forma ordenada desde una zona de riesgo hacia un lugar seguro para proteger la vida.

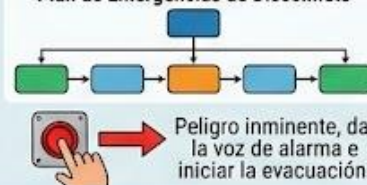
2. ¿CUÁNDO EVACUAR?



Ante sismos, incendios, fugas, amenazas, órdenes de autoridad o cualquier riesgo para la vida.

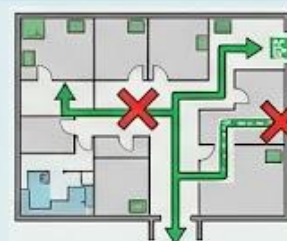
3. ¿QUIÉN ORDENA LA EVACUACIÓN?

Plan de Emergencias de Discolmets



Seguir la cadena de decisión definido en el Plan de Emergencias de Discolmets. Ante un peligro inminente, dar la voz de alarma e iniciar la evacuación.

4. CONOCER LAS RUTAS



Conocer de memoria más de una ruta de evacuación. La ruta principal puede estar bloqueada.

5. PUNTO DE ENCUENTRO



Dirigirse al lugar seguro definido por Discolmets para realizar el conteo y verificación.

6. CONTEO Y VERIFICACIÓN



Verificar que todas las personas hayan llegado. Reportar inmediatamente cualquier persona faltante. **NO** regresar a buscarla.

7. NO REGRESAR POR OBJETOS



Ningún objeto personal justifica regresar a una zona de riesgo.

8. MANTENER RUTAS DESPEJADAS



Evitar permanentemente obstáculos en pasillos, escaleras y salidas.

¿CÓMO ACTUAR ANTE UN SISMO?

Antes del sismo

- Identificar **zonas seguras**, rutas de evacuación, salidas y puntos de encuentro.
- Reconocer elementos que puedan caer: **estanterías, vidrios, lámparas y objetos altos**.
- Verificar la **señalización** y participar activamente en simulacros.
- Revisar periódicamente los **elementos de emergencia**.



Durante el sismo

- **Mantener la calma y no correr ni empujar.**
- Alejarse de **vidrios, ventanas y estanterías.**
- Proteger **cabeza y cuello** y ubicarse en una zona segura previamente identificada.
- **No evacuar mientras el movimiento sea intenso**, salvo una situación de peligro inmediato.
- Una vez sea seguro, evacuar por las **escaleras, nunca por ascensores.**



Después del sismo

- Verificar **lesionados, daños visibles, incendios o fugas**.
- Brindar primeros auxilios si es seguro hacerlo.
- Tener precaución ante **réplicas, vidrios rotos y obstáculos**.
- Activar la evacuación según el procedimiento interno
- Dirigirse ordenadamente al **punto de encuentro**, realizar el conteo y reportar novedades.

“ DESPUÉS DEL SISMO”

Verifique • Auxilie • Evacúe • Cuente • Reporte



EVACUACIÓN DE LA BODEGA DE MEDICAMENTOS

- **Dar la alarma:** el brigadista o persona cercana a la salida debe alertar y orientar la evacuación con instrucciones claras.
- **Conocer la salida:** todo trabajador debe identificar previamente la salida disponible desde su área de trabajo.
- **Durante un sismo:** no salir mientras el movimiento sea intenso; alejarse de **estanterías y puertas de vidrio** y protegerse en una zona segura.
- **Puerta de vidrio rota:** evaluar el piso, advertir sobre los vidrios y avanzar con precaución, sin generar pánico.
- **Salida bloqueada:** no forzar puertas ni romper vidrios; utilizar una **salida alterna** o solicitar apoyo.
- **Evitar aglomeraciones:** evacuar en orden, sin correr, empujar ni adelantarse.
- **Persona en pánico:** hablar con calma, dar instrucciones simples y acompañarla hacia la salida.
- **Persona atrapada:** no realizar rescates improvisados; informar al coordinador y organismos de socorro.
- **Verificar el área:** revisar rápidamente los espacios visibles **solo si es seguro**, sin exponerse al riesgo.
- **No detenerse por objetos:** dejar medicamentos, documentos, dinero, equipos y objetos personales.
- **Sustancias peligrosas:** informar su presencia a los organismos de socorro, **sin manipularlas** durante la evacuación.





**INICIO: BODEGA →
SE PRESENTA UNA
EMERGENCIA**

**¿EL SISMO
ESTÁ EN
CURSO?**

NO

SÍ

**PROTEGERSE EN EL
SITIO:**

- Alejarse de vidrios y estanterías altas.
- Esperar a que disminuya el movimiento.

**¿LA SALIDA
ESTÁ DISPONIBLE
Y DESPEJADA?**

NO

SÍ

EVACUAR

- Salir en fila, uno a la vez.
- No correr.
- Dirigirse al punto de encuentro.
- Verificar el área solo si es seguro.
- Contar al personal.

**¿EXISTE
UNA SALIDA
ALTERNA?**

NO

SÍ

**REDIRIGIR LA
EVACUACIÓN:**

- Dirigir al grupo hacia la salida alterna de forma calmada y ordenada.

**PERMANECER EN
ZONA SEGURA**

- Alejarse del riesgo inmediato.
- Alertar y solicitar apoyo.
- Informar ubicación, número de personas y condición.
- Esperar instrucciones o rescate especializado.



EVACUACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

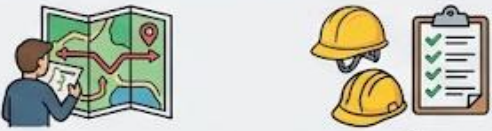


Evacuación segura por escaleras

- **Descender caminando**, nunca corriendo, usando siempre el pasamanos.
- Mantener **distancia prudente**, sin empujar, adelantarse ni detenerse en la escalera.
- **Tacones**: retirarlos solo si es seguro; ante vidrios, agua u otros riesgos, mantenerlos puestos y bajar con precaución.
- Si alguien pierde el equilibrio, **brindar apoyo inmediato** y alertar al grupo.
- A personas con dificultad para caminar, **acompañar y ajustar el ritmo**, solicitando apoyo adicional si es necesario.
- Mantener un **flujo constante**, especialmente cuando haya congestión.
- Ante una persona en pánico, dar instrucciones **simples, firmes y calmadas**.
- Evitar caídas en cadena manteniendo distancia y **advirtiendo obstáculos**.
- **La seguridad está por encima de la velocidad**: no correr, saltar peldaños ni realizar maniobras bruscas.



FUNCIONES DEL BRIGADISTA DURANTE LA EVACUACIÓN

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
 PREPARACIÓN Y PREVENCIÓN • Conocer rutas y salidas. • Verificar que estén despejadas. • Conocer el punto de encuentro. • Participar en simulacros. • Identificar personas que requieran asistencia especial.	 ORIENTACIÓN Y CONTROL • Dar la voz de alarma. • Guiar hacia las salidas. • Mantener el orden y la calma. • Evitar retornos. • Controlar el flujo en puertas y escaleras. • Asistir a quienes necesiten ayuda.	 VERIFICACIÓN Y REPORTE • Apoyar el conteo en el punto de encuentro. • Informar personas faltantes de inmediato. • Reportar novedades al coordinador de emergencias. • Permanecer disponible para nuevas instrucciones.

El brigadista debe **guiar, apoyar y coordinar la emergencia**, sin exponerse a riesgos innecesarios ni realizar acciones que superen su **capacitación o recursos disponibles**. Los rescates especializados corresponden a los **organismos de socorro**.

PRIMEROS AUXILIOS



Qué son los primeros auxilios?

Son **acciones inmediatas, básicas y temporales** para proteger la vida, evitar el empeoramiento de una persona lesionada o enferma y facilitar su atención médica.

- **Objetivo:** estabilizar a la persona hasta recibir atención especializada.
- **Alcance:** evaluar, controlar sangrados, atender desmayos, apoyar traslados seguros y **activar el sistema de emergencias**.
- **Limitaciones:** el brigadista **no diagnostica, no administra medicamentos ni realiza procedimientos** para los que no esté capacitado.
- **Importante:** los primeros auxilios **no reemplazan la atención médica**.
- **Regla fundamental:** actuar dentro de las competencias y **solicitar ayuda especializada cuando la situación lo requiera**.



¿QUÉ SON LOS PRIMEROS AUXILIOS?
Acciones inmediatas, básicas y temporales para proteger la vida

- PROTEGER
- EVALUAR
- ACTUAR
- ACTIVAR EMERGENCIAS
- ESPERAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA

ACTÚE DENTRO DE SUS COMPETENCIAS • SOLICITE AYUDA ESPECIALIZADA

EVALUACIÓN INICIAL DEL HERIDO



Antes de tocar o mover a una persona, el brigadista debe:

1. **Verificar la seguridad:** confirmar que no existan riesgos activos en el lugar.
2. **Evaluar la conciencia:** hablarle y comprobar si responde.
3. **Revisar la respiración:** verificar si respira normalmente.
4. **Identificar lesiones:** observar heridas, deformidades o dolor evidente.
5. **Verificar sangrados:** identificar su presencia y gravedad aparente.
6. **Activar ayuda:** solicitar atención médica cuando la situación lo requiera, según el protocolo interno.
7. **Regla clave:** primero **proteger**, luego **evaluar** y finalmente **actuar**, sin exponerse ni mover a la persona innecesariamente.

“EVALUACIÓN INICIAL DEL HERIDO”



PRIMERO PROTEGER • LUEGO EVALUAR • FINALMENTE ACTUAR

- | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|
|  1. Verifique la escena |  2. Evalúe la conciencia |  3. Revise la respiración |  4. Identifique lesiones |  5. Controle sangrados |  6. Active ayuda |
|--|---|--|---|---|---|

METODOLOGÍA ERA

Escena → Responde → Activa

E — ESCENA



¿La escena es segura?

R — RESPONDE



¿La persona reacciona, respira, tiene lesiones visibles o sangrado?

A — ACTIVA



¿Es necesario activar ayuda médica de inmediato?

Actuar de forma ordenada incluso bajo el estrés de una emergencia.

ATENCIÓN A USUARIOS O PERSONAL INTERNO



Atención según el tipo de persona

La atención debe ser **segura, respetuosa y oportuna**, independientemente de quién sea la persona lesionada.

- **Usuario:** brindar atención y explicar con calma lo que ocurre. Si tiene acompañante, solicitar información útil para la atención.
- **Trabajador:** brindar primeros auxilios y activar el **procedimiento interno de accidente de trabajo**.
- **Visitante o contratista:** identificar, si es posible, a su responsable dentro de la organización, sin retrasar la atención.

Prioridad en todos los casos: evaluar, atender, activar ayuda y proteger, siempre dentro de las competencias del brigadista.

ACTUACIÓN INICIAL SEGÚN EL TIPO DE LESIÓN

ESCENARIO	CONSIDERACIÓN CLAVE
 CAÍDA	EVALUAR ANTES DE MOVER ; sospechar lesión de columna o extremidades si hubo golpe fuerte o caída desde altura.
 GOLPE	Observar confusión, mareo o vómito; ACTIVAR AYUDA MÉDICA si es necesario.
 HERIDA	Evaluar profundidad y sangrado; USAR ELEMENTOS DE BARRERA antes de tocar.
 CORTADURA	Controlar sangrado con presión directa; evaluar si requiere sutura profesional.
 QUEMADURA	NO APLICAR REMEDIOS CASIROS ; enfriar con agua limpia si es leve y activar ayuda si es extensa o profunda.
 SANGRADO	Aplicar presión directa con barrera; activar ayuda urgente si es abundante o no cede.
 DESMAYO	Verificar respiración; proteger a la persona; no dar líquidos si está inconsciente.
 MAREO	Sentar o recostar en un lugar seguro y ventilado; observar evolución.
 CRISIS DE ANSIEDAD	Hablar con calma, alejar de estímulos y acompañar sin dejarla sola.
 LESIÓN DURANTE UN SISMO	Evaluar primero el riesgo estructural antes de acercarse.
 LESIÓN DURANTE UNA EVACUACIÓN	Evitar bloquear la ruta; trasladar a un punto seguro cercano si es posible sin riesgo.

HERIDAS Y HEMORRAGIAS

Una **hemorragia** es la pérdida de sangre fuera de los vasos sanguíneos. Puede ser **externa (visible)** o **interna (no visible)**.

Para controlar un sangrado externo:

1. Usar **guantes o barrera de protección**.
2. Cubrir la herida con gasa o tela limpia.
3. Aplicar **presión firme y constante**.
4. Si la gasa se empapa, colocar otra encima **sin retirar la anterior**.
5. Mantener la presión hasta controlar el sangrado o recibir ayuda.

No hacer: retirar objetos incrustados, aplicar sustancias caseras o utilizar torniquetes sin capacitación específica.

Solicitar ayuda médica urgente ante sangrado abundante, heridas profundas, sospecha de hemorragia interna o signos como **palidez, debilidad, confusión o pérdida de conciencia**.



DESMAYO O PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO



QUÉ HACER



VERIFICA LA SEGURIDAD DEL LUGAR
Asegúrate de que el entorno sea seguro para ti y para la persona.



VERIFICA LA RESPUESTA Y LA RESPIRACIÓN
Habla en voz alta y sacude suavemente los hombros. Verifica si responde y si respira normalmente.



COLOCA EN POSICIÓN LATERAL DE SEGURIDAD
Si está inconsciente pero respira, colócala de lado para mantener la vía aérea abierta.



AFLOJA LA ROPA APRETADA
Afloja el cuello, la corbata, el cinturón u otras prendas ajustadas.



MANTÉN LA VENTILACIÓN
Asegura aire fresco y una temperatura adecuada en el lugar.



MONITOREA SU ESTADO
Observa su respiración y nivel de conciencia hasta que se recupere o llegue ayuda.



QUÉ NO HACER



NO LE DES ALIMENTOS, LÍQUIDOS NI MEDICAMENTOS
Podría atragantarse o empeorar su condición.



NO LO SACUDAS NI HAGAS MOVIMIENTOS BRUSCOS
Puede causarle más daño.



NO LO DEJES SOLO NI EN LUGARES CONCURRIDOS
Quédate con la persona y mantén un ambiente tranquilo y seguro.



LLAMA A AYUDA DE EMERGENCIA SI



NO RECUPERA EL CONOCIMIENTO
Después de unos minutos.



NO RESPIRA NORMALMENTE
O deja de respirar.



TIENE DIFICULTAD PARA RESPIRAR
O presenta respiración irregular.



HA SUFRIDO UN GOLPE SEVERO
En la cabeza o el cuerpo.



MUESTRA SIGNOS DE LESIÓN GRAVE
Sangrado abundante, dolor intenso, deformidades o convulsiones.



REGLA CLAVE:



**VERIFICAR
SEGURIDAD**



**VERIFICAR
RESPUESTA**



**VERIFICAR
RESPIRACIÓN**



PROTEGER



**ACTIVAR
AYUDA**



TU ACCIÓN PUEDE MARCAR LA DIFERENCIA.



CAPACÍTATE EN PRIMEROS AUXILIOS



CUÍDATE A TI, CUIDA A LOS DEMÁS



LA PREVENCIÓN Y LA PREPARACIÓN SALVAN VIDAS

RCP Y USO DEL DEA



PARO CARDIORRESPIRATORIO (PARO CARDIORRESPIRATORIO)



¿CUÁNDO SOSPECHAR UN PARO CARDIORRESPIRATORIO?

La persona está inconsciente y no respira normalmente o respira de forma anormal.



¿QUÉ HACER?

1

ACTIVE INMEDIATAMENTE



Active el sistema de emergencias.



2

SOLICITE EL DEA



Solicite el DEA, si está disponible.



3

INICIE LAS COMPRESIONES TORÁCICAS



Realice compresiones firmes, continuas y en el centro del pecho.



4

UTILICE EL DEA



Siga sus instrucciones al pie de la letra. No toque a la persona durante el análisis o la descarga.



REGLA CLAVE:



RECONOZCA



ACTIVE LA AYUDA



INICIE RCP



USE EL DEA



CONTINUE HASTA QUE LLEGUE LA AYUDA



IMPORTANTE:



La RCP y el uso del DEA requieren capacitación práctica certificada y cursos de actualización periódica.

¿CÓMO EVACUAR A UNA PERSONA HERIDA?

01



MOVER SOLO SI HAY PELIGRO INMINENTE

Mover solo si existe peligro inminente, como incendio, colapso o humo denso.

02



NO MOVER SI EL ESCENARIO ES SEGURO

Si el escenario es seguro, no mover innecesariamente, especialmente si se sospecha lesión en la columna vertebral.

03



SOSPECHA DE LESIÓN EN LA COLUMNA VERTEBRAL

En casos de caídas, golpes fuertes o accidentes de causa desconocida, considerar posible lesión en la columna vertebral.

04



ACTIVAR AYUDA ESPECIALIZADA

Activar ayuda especializada y reportar ubicación, condición de la persona y tipo de emergencia.

05



TRASLADO SEGURO

Si el traslado es esencial, realizarlo de manera coordinada y segura, con el apoyo de varias personas siempre que sea posible.



REGLA CLAVE: SI NO HAY PELIGRO INMEDIATO, NO MUEVAS A LA PERSONA.

CONTROL DEL FUEGO



¿Qué es el fuego?

El fuego es una **reacción química de combustión** que requiere cuatro elementos, conocidos como el **tetraedro del fuego**:

- **Combustible:** material que puede arder.
- **Oxígeno:** permite mantener la combustión.
- **Calor:** inicia y sostiene el fuego.
- **Reacción en cadena:** mantiene y propaga la combustión.

Regla clave: al eliminar cualquiera de estos cuatro elementos, **el fuego se extingue**. Los extintores actúan eliminando o reduciendo uno o varios de ellos.



CLASES DE FUEGO

Clase	Símbolo	Pictograma	Materiales	Ejemplos
A			Materiales combustibles ordinarios	Madera, papel, tela, caucho y muchos plásticos
B			Líquidos y gases inflamables	Gasolina, grasas de petróleo, alquitranes, aceites, pinturas a base de aceite, solventes, alcoholes, propano y butano
C			Equipos eléctricos energizados	Computadoras, servidores, motores, transformadores y electrodomésticos
D			Metales combustibles	Magnesio, titanio, circonio, sodio, litio y potasio
K			Aceites y grasas de cocina	Grasas animales y vegetales

EXTINTORES

Clase	Material	Extintor recomendado
A	Madera, papel, cartón y telas	Agua, espuma o polvo ABC
B	Gasolina, aceites, pinturas y solventes	Polvo ABC, espuma o CO ₂
C	Equipos eléctricos energizados	CO ₂ o polvo químico seco
D	Metales combustibles	Polvos especiales para metales
K	Grasas y aceites de cocina	Acetato de potasio



Cada extintor debe estar:

- **Señalizado, visible y accesible.**
- **Con recarga y mantenimiento vigentes.**
- **Con el manómetro en el rango correcto, si aplica.**
- **Con el pasador de seguridad intacto.**
- **Sin obstáculos que dificulten su uso inmediato.**

Regla clave: revisar periódicamente los extintores mediante el **checklist de la brigada** y reportar cualquier anomalía.

MANEJO DE EXTINTORES

Uso del extintor: método PASS

P — Pasador: retirar el pasador de seguridad.

A — Apuntar: dirigir la boquilla hacia la **base de las llamas**.

S — Presionar: accionar la manija para liberar el agente extintor.

S — Barrer: mover la boquilla de lado a lado, cubriendo la base del fuego.

Regla clave: utilizar el extintor solo si el fuego es pequeño, existe una ruta de escape segura y se cuenta con capacitación.



MATRIZ DE DECISIONES DURANTE UNA EMERGENCIA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO • PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE EMERGENCIAS

 SITUACIÓN	 PRIMERA ACCIÓN	 SEGUNDA ACCIÓN	 ¿EVACUAR?	 ¿USAR EXTINTOR?	 ¿SOLICITAR APOYO?
 SISMO	Protegerse en sitio seguro.	Evaluar condiciones tras el movimiento.	Sí, si corresponde tras evaluación.	No aplica.	Sí, según daños encontrados.
 INCENDIO PEQUEÑO (CONATO)	Alertar.	Evaluar condiciones de seguridad para intervenir.	Solo si el conato crece o no se controla.	Sí, únicamente si es seguro y adecuado.	Sí, siempre se informa.
 INCENDIO FUERA DE CONTROL	Alertar de inmediato.	Evacuar sin intentar controlarlo.	Sí, de inmediato.	No.	Sí, urgente.
 HUMO	Alertar.	Evaluar densidad y evacuar si es necesario.	Sí, si el humo se intensifica.	No, salvo conato claramente identificado y controlable.	Sí.
 PERSONA LESIONADA	Evaluar seguridad de la escena.	Brindar primeros auxilios según competencia.	Depende del contexto de la emergencia.	No aplica.	Sí, siempre.
 PERSONA INCONSCIENTE	Verificar respiración.	Activar RCP si no respira / posición lateral si respira.	Depende del contexto de la emergencia.	No aplica.	Sí, urgente.
 SALIDA BLOQUEADA	Buscar salida alterna.	Permanecer en zona segura si no hay alterna.	Sí, por ruta disponible.	No aplica.	Sí, si hay lesionados ubicación exacta.
 PERSONA ATRAPADA	Alertar de inmediato.	Evacuar al resto del personal.	Sí, del resto del grupo.	No aplica.	Sí, urgente, apoyo especializado.
 EVACUACIÓN POR ESCALERAS	Organizar el flujo.	Asistir a personas con dificultad.	Sí.	No aplica.	Sí, si hay caídas o congestión severa.

RECOMENDACIÓN: Actuar con calma • Priorizar la seguridad del personal • Seguir los protocolos internos • Comunicar siempre a la brigada de emergencia y al supervisor



DISCOLMETS

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD



SC6897-1



SA-2003084



ST-2003085



GRACIAS